

Tortícolis en pediatría

Tortus (torcido) y *collum* (cuello), se define como una condición clínica caracterizada por una inclinación anormal de la cabeza hacia un lado, resultante de una contractura de la musculatura cervical. Esta condición no constituye una patología en sí misma, sino que es la manifestación secundaria de una amplia gama de entidades subyacentes, cuyo diagnóstico diferencial es crucial para un manejo adecuado. La semiología del paciente, incluyendo la forma de comienzo y la evolución, es fundamental para orientar la etiología.

Clasificación Etiológica

- **Tortícolis Doloroso**

Origen Traumático: Puede ser consecuencia de una lesión directa sobre las estructuras osteoarticulomusculares del cuello. Incluye desde una contractura muscular aguda de los músculos esternocleidomastoideo, escalenos o paravertebrales por posiciones forzadas, hasta lesiones óseas severas.

También puede ser secundaria a **subluxaciones o luxaciones de las facetas**

articulares cervicales, especialmente a nivel occipitoatloideo y atlantoaxoideo, donde la contractura muscular actúa como un mecanismo de protección reflejo. En atletas, deben considerarse las **fracturas por estrés**, que no son visibles en radiografías convencionales.

Origen Infeccioso: Procesos infecciosos en regiones adyacentes al cuello, como faringitis u otitis, pueden causar adenopatías dolorosas y una contractura reactiva. Una entidad específica es el

Síndrome de Grisel, que consiste en una subluxación rotatoria de la articulación atlantoaxoidea por distensión ligamentaria secundaria al edema de un proceso infeccioso cercano. La osteomielitis vertebral, aunque menos común, también puede manifestarse con dolor y contractura refleja.

Origen Tumoral: Masas ocupantes en las partes blandas del cuello, la fosa posterior o el canal raquídeo pueden comprometer raíces nerviosas y generar una tortícolis secundaria. Característicamente, la evolución no es aguda y la inclinación de la cabeza puede ser contralateral al tumor para evitar su compresión.

Origen Reumatológico: Patologías como la **Artritis Reumatoidea Juvenil** son una causa reconocida de tortícolis, especialmente en presentaciones crónicas o recidivantes.

Origen Psicogénico: En algunos casos, la tortícolis puede ser una manifestación de somatización por estrés o parte de una crisis de conversión.

- **Tortícolis Indoloro**

Origen Congénito: Puede deberse a anomalías de partes blandas, como la fibrosis del músculo esternocleidomastoideo (conocido como **tortícolis muscular congénito**), hipoplasias musculares o pterigium colli. También existen causas óseas, como defectos de formación y/o segmentación de la columna cervical (ej. Síndrome de Klippel-Feil) y displasias esqueléticas.

Origen Neurológico y Neuromuscular: Se asocia a condiciones como la parálisis cerebral, distonías, distrofias musculares o complicaciones mecánicas como la tracción de catéteres de derivación ventrículo-peritoneal.

Origen Oftalmológico: Alteraciones visuales pueden llevar al paciente a adoptar una posición anómala de la cabeza para compensar el déficit.

Abordaje Diagnóstico

Estudios de Imagen:

Radiología: El par radiográfico simple (proyecciones de frente y perfil) suele ser suficiente inicialmente, pudiendo mostrar una rectificación de la lordosis cervical fisiológica. Para evaluar el complejo occipitoatlantoaxoideo (C1-C2), es indispensable una **proyección transoral**.

Tomografía Computarizada (TC): Es mandatoria en pacientes con politraumatismo o trauma craneal para descartar lesiones óseas. La TC con reconstrucción tridimensional es el método de elección para el diagnóstico de luxaciones y subluxaciones.

Resonancia Magnética (RM): Se indica ante la presencia de signos neurológicos para evaluar el compromiso del sistema nervioso central y el neuroeje.

Centellograma Óseo y SPECT: Son de gran utilidad para detectar lesiones no visibles por otros métodos, como fracturas por estrés, focos infecciosos (osteomielitis) o tumores.

Consideración Especial: SCIWORA: En niños menores de 8 años, se debe tener un alto índice de sospecha para la **Lesión Medular Traumática sin Correlato Radiológico** (SCIWORA, por sus siglas en inglés). Debido a la laxitud ligamentaria, puede ocurrir un daño medular severo sin evidencia de fractura o luxación en las imágenes. El déficit neurológico puede instaurarse hasta 4 días después del trauma inicial.

Estudios de Laboratorio

Un hemograma con fórmula y una eritrosedimentación pueden orientar hacia un origen infeccioso o tumoral. Estudios adicionales como hemocultivos, proteína C reactiva y colagenograma se solicitarán según la sospecha clínica.

Manejo y Tratamiento

- **Tortícolis Muscular Agudo:** El manejo es conservador, con **antiinflamatorios no esteroideos (AINEs)**, relajantes musculares, por ejemplo Diazepam, Pridinol (Relaxedan Pridinol ®) o combinación: Clorzoxazona + ibuprofeno (Ibupirac Flex®) y fisioterapia.
- **Causas Específicas:**
 - **Infeccioso:** Requiere AINEs y antibioticoterapia dirigida a la patología de base.
 - **Reumático:** Se maneja con AINEs y un collarín de Schanz.
 - **Fracturas y/o Luxaciones:** Necesitan inmovilización inicial y manejo por un especialista para su reducción y estabilización.
 - **Lesiones Expansivas:** En caso de compromiso neurológico, puede ser necesaria una cirugía descompresiva o de resección.

Las complicaciones de la tortícolis son aquellas inherentes a su patología de base. La persistencia del dolor en un tortícolis muscular agudo debe hacer sospechar una fractura por estrés no diagnosticada.